

Fecha Última Actualización: 28-09-2022 22:45:52

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre : Daniela Francisca Olivares Garmendia
Edad : 28a 11m 23d
Dirección : Pasaje El Pampano 1681 Dpto. 211

Rut : 18.499.171-3
Fecha Nacto: 05/10/1993
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2200234
Sexo : Femenino
Teléfono : 9 8476 6755

N° Epicrisis
323002

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Unidad Intermedio Coronaria

Fecha Ingreso : 04/09/2022 10:50

Días Estadía : 24

Unidad de Egreso : Unidad Intensivo Coronaria

Fecha Egreso : 28/09/2022 22:09

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

dolor toracico

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Daniela Olivares Garmendia
Rut 18499171-3
28 años
FIHSR 13/08
FIHSJD 25/08
F reingreso HSR 03/09

Antecedentes:

Médicos:

- Vasculitis ANCA orbitaria derecha, en controles en Hosp. Salvador.

Diagnóstico a los 8 años por biopsia ocular. Desde entonces con tratamiento inmunosupresor, el cual se ha mantenido siempre con micofenolato 3g al día + pdn porque refiere que al intentar bajarlo, presenta reactivación de la vasculitis, la cual siempre se manifiesta por ojo rojo doloroso, con disminución de la agudeza visual. Refiere que entre 2019-2021 tuvo al menos 8 episodios de ojo rojo, por lo que su reumatólogo le indicaba a distancia subir la pdn a 80 mg al día, con lo que cedía.

Otitis, sinusitis, bronquitis recurrente (-) hematuria (-)

- Enero 2022: MINOCA infarto transmural en territorio de Cx (RM cardiaca), TV monomorfa

Hospitalizaciones recientes:

Enero-Febrero 2022 HSR: dolor torácico. Cursa con TV 220 lpm persistente tras 6 CVE, bic de amiodarona y lidocaína. Se realiza IOT y VMI. Evoluciona con shock cardiogénico transitorio, con troponinas hasta 14.000. Estudio coronario sin lesiones, ecocardiograma FE 30%, hipocinesia difusa, severo compromiso de la función sistólica global. RM cardiaca: infarto transmural ACx.

Se interpreta en contexto de la vasculitis, por lo que se solicita angioTC tap que no muestra más territorios afectados, se pide: complemento normal, VHS 14, perfil ENA (-) ANA (-), ANCA (-) por IFI, TSH normal, antiB2GP1 (-), anticL (-). Recibe metilprednisolona 1.5 g + prednisona 1 mg/kg por 15 días, además del micofenolato 3 g.

Cursa con AKI pre renal por FeNA y FeBUN, IPC normal, aunque leve leucocituria 7-10pc.

En lo oftalmológico, es evaluada por especialidad y describen probable orbitopatía distiroidea. Se toma angioRM cerebro que resulta sin alteraciones.

Febrero- Marzo 2022 HSR: Consulta por síntomas respiratorios altos asociado a disnea progresiva y signología obstructiva respiratoria, requiriendo VMI. IOT difícil por edema glótico, por lo que recibe adrenalina im. Se rescata PCR

Fecha Epicrisis : 28/09/2022 22:45

Página 1 de 4

Fecha Última Actualización: 28-09-2022 22:45:52

Página 2 de 4

COVID19 (+). Se extuba a los 8 días y se interpreta como etiología asmática? dado ausencia de condensaciones u otros vistos en el parénquima pulmonar.

Cursa con NAVM por PSAE MS e ITU por E coli.

Evoluciona sin episodios de TV ni descompensación de la IC. Se suspende micofenolato y se mantiene con prednisona.

Quirúrgicos: biopsia ocular

Gineco-obstétricos: implanon hace 2 años. Una hija de 3 años, la cual nació de término, sin haberse enterado que estaba embarazada hasta el final porque persistió con sangrados regulares. Paridad cumplida. Sin pareja actualmente.

Fármacos: micofenolato 1.5 g c/12h, prednisona 5 mg al día, buena adherencia al tratamiento, amiodarona 200 mg al día, carvedilol 25 mg c/12h, omeprazol, elcal D, quetiapina

Hábitos: TBQ,(-) OH (-) Drogas (-) act física (-)

Alergias: diclofenaco

Vacunas: COVID19 4 dosis

Sociales: cesante

Familiares: sin familiares con enfermedades reumatológicas ni cardiológicas.

Historia:

Consulta por dolor torácico de 2 días de evolución. En APS se toman tropo 18.437 por lo que se deriva a este centro. En 24 hrs evoluciona con shock cardiogénico, con FE 15% por ecocopia, con akinesia de pared anterior e inferior e insuficiencia mitral severa. Coronariografía sin lesiones significativas. Requiere apoyo con noradrenalina, milrinona 0.3 ug/kg/min y balón de contrapulsación aórtica (este último por 2 días). Recibe metilprednisolona 3 g en total (16 al 18/08), luego prednisona 60 mg al día, y se mantiene el micofenolato en 3 g al día. Evoluciona estacionaria, requiriendo agregar BNM para optimizar la oxigenación. Se realiza ecocardiograma de seguimiento el 20 y 22/08 que describe persistencia de la disfunción ventricular e insuficiencia mitral masiva funcional (tracción apical de ambos velos y dilatación del anillo mitral).

Se traslada a HSJD con plan de asistencia ventricular al no poder progresar en el weaning. Se describe que se realiza ecoTE que evidencia trombo en VD por lo que se inicia anticoagulación.

Además, se hace Tc de tórax que muestra pequeño foco de condensación periférico en segmento basal posterior del LID y posterior izquierdo, y derrame pleural laminar.

Se realiza ecocardiograma, descrito más abajo, que muestra recuperación de la FE.

Logra weaning el 27/08 y suspensión de DVA por lo que se traslada nuevamente a este centro. Se inicia terapia médica de IC FEr.

Reumatológico: Paciente recibe pulsos de metilprednisolona, luego hidrocortisona y prednisona. En seguimiento por equipo, indican mantener prednisona 40 mg al día por 4 semanas (desde el 03/09) y luego decalaje progresivo, mantener micofenolato 3 gr/ día y por sospecha de compromiso cardiaco de origen reumatológico recomiendan pulsos de ciclofosfamida 500 mg cada 14 días por 6 veces (con toma de hemograma previo a cada pulso) posterior a toma de biopsia endomiocárdica.

Oftalmológico: Presenta durante hospitalización dolor ocular, fotofobia y epifora OD, evalúa por oftalmología les impresiona queratitis infecciosa, se inicia tratamiento con moxifloxacino tópico. Reevaluada, toman cultivo y se mantiene tratamiento con moxifloxacino y se agrega azitromicina con lo que completar 6 días. Pendiente control el 11/10.

Nefrológico: Paciente cursa con múltiples episodios de hipokalemia leve que corrigen con carga de K ev, pero que recurren. Se realiza IC a nefrología.

Laboratorio relevante a la fecha:

Enero- feb 2022:

VIH (-) HBsAg(-) VHC (-). Complemento normal, VHS 14, perfil ENA (-) ANA (-), ANCA (-)por IFI, TSH normal, antiB2GP1 (-), anticL (-).

Agosto 2022

VHS 15 ANCA (-)por IFI, ELISA PR3 (-) antiDNA (-), ANA (-)perfil ENA (-) IgA 198 (N) IgG 806 (N) IgM 63(N), C3 136 (N) C4 34 (N), FR <10

VDRL NR

Imágenes:

Enero 2022

Ecocardiograma TT: FE 30%, hipocinesia difusa y severo comp de la fx sistólica global.

Fecha Epicrisis : 28/09/2022 22:45

Página 2 de 4

Fecha Última Actualización: 28-09-2022 22:45:52

Página 3 de 4

Coronariografía: sin lesiones.
RM cardíaca: infarto transmural en territorio de Acx.

Febrero 2022:

Holter de ritmo normal (Dr Alegría)

angioTc tórax: sin signos de Sd aórtico agudo ni TEP. Atelectasias subsegmentarias en lóbulos inferiores.

Agosto 2022

26/08 ecoscopia HSJD: dilatación de cavidades izquierdas FE 30%, aquirseia segmento mediobasal pared inferior. Válvula mitral de velos finos, tenting 1.1 cm , reflujo central severo, vena contracta 8 mm. EcoTE evidencia gran trombo VD

22/08 Ecocardiografía portatil, paciente en VMI (Dr Zapata):

VI dilatado, con disfunción sistólica FE 48% con milrinona 0.3, con insuficiencia mitral.PFDVI elevada. AI con dilatación severa. Reflujo mitral severo, funcional, en válvula con leve engrosamiento en borde de coaptación. VD dilatado leve, con función normal.

17/08: angioTc cerebro y cuello: sin hallazgos patológicos.

Resonancia magnética cardíaca: HSR 09 09 2022:

No se apreció endocarditis, tiene múltiples áreas de infartos subendocárdicos pequeños, de los tres territorios, algunos transmurales, cicatriz inferior. Cavidades dilatadas, con disfunción severa, FEVI: 25%, no se aprecian aneurismas coronarios. Muchos de los hallazgos pudieran estar en contexto de shock profundo. Insuficiencia mitral en vías de mejoría.

Diagnóstico:

POP inmediato:28/09/22 : by pass venoso ADA, drenaje pericárdico

PCR intraoperatorio: 6 veces, 1-2 min cada evento

Biopsia endomiocárdica: 28/09/22

PCR en asistolia post biopsia inmediata recuperado, aproximado 30 minutos.

Toracotomía lateral izquierda de emergencia

Shock mixto: cardiogénico y hemorrágico:

Taponamiento cardíaco x lesión micardica post biopsia miocárdica

Antecedentes:

1. Shock Cardiogénico Resuelto.

- IC FEr (FEVI 15%) en recuperación ---> FEVI 29%

- Insuficiencia mitral severa secundaria a dilatación de cavidades izquierdas.

- Edema pulmonar en resolución.

- Trombo intracavitario VD.

2. SCA/SEST 13/08/22

- CNG sin lesiones

- RM cardíaca con IAM en los 3 territorios vasculares.

3. Obs Vasculitis ANCA (+)

- Inmu nosupresión secundaria.

4. ITU x E. coli sensible tratada

5. Antecedente de TV monomorfa Enero 2022

6. Alergia diclofenaco/ yodo.

Hemodinamia: Desde reingreso a HSR sin req de DVA. Se mantiene con terapia médica de IC FEr, sin diureticos de asa, con tendencia a la hipotensión siempre asintomática y con microhemodinamia conservada.

Cardiologico: Se mantiene con anticoagulación por trombo en VD y an t iagregación + ATV, en contexto de infarto transmural en territorio de Cx en RNM. Durante esta hospitalización se realiza nueva RNM y posteriormente por duda etiologica de compromiso cardíaco se realiza biopsia endomiocárdica. El 28/09/22, se realiza biopsia endomiocárdica, posterior a procedimiento presenta PCR, secundario a taponamiento cardíaco, por lesión ventriculo, derecho, requiriendo toracotomía de emergencia, ingresa a pabellón se realiza dreanje pericardico, y by pass venoso a ADA, evoluciona con shock mixto profundo

Fecha Epicrisis : 28/09/2022 22:45

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 28-09-2022 22:45:52

Página 4 de 4

(distributivo, cardiogénico), disfunción ventricular severa FEVI 5-10%, se comenta con UCI, se activa ECMO, sin embargo paciente requerimiento elevado de DVA e inotropo, y evidencia de isquemia gastrointestinal, mal perfundida clínicamente. Fallece 20:20.

Diagnóstico de Egreso

Insuficiencia cardíaca - shock cardiogenico
Taq Ventricular monomofica.
IAM territorio de arteria circunflaja con coronariografia sin evidencia de lesiones.
Antecedente de vasculitis Anca(+), ocular.
OBs . sospecha de vasculitis, no confirmada, miocardica.

Condición de Egreso

fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Plan Post Alta

fallecido

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO



Antonia Estruch Ferna
Becado/Residente



Juan Pablo Ipanaque Alfaro
Médico Tratante (Staff)